



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ميرفت سيد احمد توفيق
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : البساتين
رقم البطاقة : 28211300103088 رقم التليفون : 01282080698
العمر (تاريخ الميلاد) : 30-11-1982 المهنة : ربه منزل
العنوان : البساتين
تاريخ تسجيل الإستمارة : 07-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي
الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونك [14157]
التعليق على التشخيص : -----
قسم العلاج :
الاورام

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ميرفت سيد احمد توفيق National ID: 28211300103088	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Patient Name : الأستاذ / ميرفت سيد احمد توفيق
Patient No. : 28211300103088
Path No. : 3075/23
Sex : Female
Age : 40 Y
Referring Doc :

Request No. : 13006179
Request Date : 12/09/2023
Verification Date : 02/10/2023
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass.

Nature of the specimen: Right wide local excision and sentenil lymph node biopsy specimens , collected at 12/9/23.

Gross Examination:

Five specimens were recieved :

-Sentenil lymph node biopsy: Fibrofatty tissue peice measured 5.5x4x3 cm , enclosing 7 nodules up to 1.5x1 cm.

-Extra deep margin: Fibrofatty tissue peice 3x2 cm , unremarkable grossly.

-Extra lateral margin: Fibrofatty tissue peice 2x2 cm , unremarkable grossly.

-Extra superior margin: Fibrofatty tissue peice 2x1.5 cm , unremarkable grossly.

-Right wide local excision specimen measured 6x5.5x3 cm with covering skin elipse measured 5x2 cm

• Tumor extent

o Number: An ill defined firm greyish white mass.

o Size: 3x2x1.5 cm.

o Skin involvement: Free grossly.

• Distance from margins: 0.3 cm from deep margin (least margin)

• Frozen section:

-Suspecious superior and deep margin.

-Free other margins and extra margins.

Microscopic examination:

• Histological type: Invasive duct carcinoma

• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)

• Angioinvasion: Not detected

• Ductal carcinoma in situ: focal

• Lymph node involvement: Free (0/7) .

• Resection Margins: Free all resected margins and extra margins.

Verified by :

Printing Date : 02/10/2023 12:50:39

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa

Name: ميرفت سيد احمد		
MR. : 4238		
Detailed Medical Report		
		السيد
تخية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه 44-year-old female, premenopausal, ER 8/8, PR 6/8, clinically T2N0 breast cancer. Treatment History: · Underwent upfront Rt BCS + SLNB (pathology T2N0). · Received adjuvant chemotherapy: TC regimen. · Received PORT · Kept on adjuvant tamoxifen.(recieved today) zometa recieved 15/11/2025 as DEXA scan show osteopenia Follow-up: · Abdominal ultrasound (Sep 2025): normal. · Bilateral breast ultrasound (Oct 2025): normal; scheduled for annual follow-up. TAMOXIFEN 20 MG CALC IUM 1*1*90 ONEALPHA ZOMETA 4 MG today for zometa Wt 56 kg after labs tan 20mg + ca + bone care for 3 mn		
تحريرا في ,		
	الوقت :	19-09-2026 التاريخ :
علياء احمد أبو النصر شهاب الدين		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذ / ميرفت سيد احمد توفيق	Request No. : 13006670
Patient No. : 28211300103088	Request Date : 08/08/2023
Path No. : 2553/23	Verification Date : 20/08/2023
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 40 Y	Department : Out Patient
Referring Doc. :	IHC No. :
	Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical data:

Right breast lesion.

Nature of specimen:

tru cut biopsy, collected at 8/8/2023 , 9:43 am

Gross examination

five greyish white tissue cores up to 1 cm , totally submitted.

Microscopic examination:

Histological type: Invasive duct carcinoma .

Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II .

DCIS:Focal.

Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy recieved.

IPT:

ER:Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8)

PR:Moderate nuclear reaction in 60% of tumor cells (Allred score 6/8)

Her-2: Weak membrane reaction in 10% of tumor cells (score 1+)

ki 67: 50 % nuclear reaction in tumor cells

Positive control showed appropriate reactivity

Diagnosis:

Right breast lesion, tru cut biopsy:

invasive duct carcinoma, Grade II .

PT:

ER: Positive (score 8/8).

PR: Positive (score 6/8).

Verified by :

dr.esraa magdy

قسط دلت
د/احمد سيد احمد
08/08/2023

Printing Date : 21/08/2023 09:37:34

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed yousse

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Populationالبرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:

1- Name : ميرفت سيد احمد توفيق

Sex:

3- Medical number:

Female

83158922

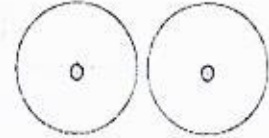
Old Med :

Old Med:

3162-2023

2-ID number: 28211300103088

Patient Age : 41 Y



Family history

Family History

+VE

Phone

Phone

01282080698

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT
Reason of MDT

marital status

Marital Status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

08/04/2024

Co morbidity

Co morbidity

CS : 7 months
ago (lactating)Menopausal
status

Menopausal Status

Pre-Menopausal

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

pelvic abdomen U/S : Free

CT chest : free

BX
IDC

BX COMMENT

ER
S/S

ER COMMENT

PR
6/8

PR COMMENT

Her 2 Neu

Her 2 Neu COMMENT
-VE

SISH

SISH COMMENT

Ki67
50T
2N
0M
0

Sonomammography

RT: upper central mass 12-1 o'clock about 19*17mm

PATIENT HISTORY

RT BCS+SLNB:

free margins

T2NO LN 0/7

PT RECEIVED to X4 --> porth--> tam

BRCA 2 :+VE (not for PARP inhibitor)

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

For Risk reducing Laparoscopic bilateral salpingo-oophrectomy

, continue hormonal ttt

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د. نور قاسم د. آلاء جميل	RADIOLOGY	RADIOLOGY د. ابراهيم عبدالحكيم
SURGERY	SURGERY د. محمود عتر	PATHOLOGY	PATHOLOGY د. ابراهيم عبدالحكيم
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

Date : 26/10/2025	Patient Name: Mervat Sayed Ahmed Tawfik
Age : 43 Year(s)	Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)
Pat. ID: 41185	Medical ID: 3162/2023

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Post Right CBS and ALAND followed by radiotherapy, routine follow up study.

Findings:

Right breast.

- Heterogeneously dense breast ACR c)
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- UOQ, posterior third architectural distortion with no speculations, masses, asymmetry , or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated UOQ area of parenchymal disruption underneath the operative scar with no solid , cystic lesions or fluid collections.
- Thickened skin reaching 5 mm and coarsen trabeculae.
- Normal nipple/areola complex.
- Clear right axilla. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes

Left breast.

- Heterogeneously dense breast ACR c)
- UOQ circumscribed heterogeneous fat containing heterogeneous density
- No speculations, masses asymmetry , distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated 2 o'clock zone c capsulated heterogeneous fat containing lesion , measures 3 x 2.5 cm , correspond to mammographic finding , likely hamartoma
- no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

- **Right breast (BIRADS 2): Post-therapeutic sequelae.**
- **Left breast (BIRADS 2): 2 o'clock hamartoma**

Recommendation:-

- **For annual follow up.**

Best Regards,
DR. Rania Ahmed , MD .

Patient Name: Mervat Sayed Ahmed Tawfik	Date : 21/08/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 40 Year(s)
Medical ID: 3162/2023	Pat. ID: 41185

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Findings:

- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- *Essentially normal CT study of the chest.*

Dr.Muzainah Rushdi

Signature Prof. Menna Tallah-Hanafy

29/08/2023 4:58 PM

Request Name : الأستاذ / ميرفت سيد احمد توفيق
Patient No. : 28211300103088
Path No. : 3075/23
Sex : Female
Age : 40 Y
Referring Doc :

Request No. : 13006179
Request Date : 12/09/2023
Verification Date : 02/10/2023
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Diagnosis:

Right breast mass , wide local excision and sentenil lymph node biopsy specimens:

- Invasive duct carcinoma , grade II.
- Free all resected margins and extra margins.
- Free nodes (0/7).
- Stage : pT2 , pN0.

Prof.Gamal Abdelatty
Dr.Esraa Magdy

Verified by :

Printing Date : 02/10/2023 12:50:39

Page 2 of 2

Printing By : Ali mostafa

Patient Name : ميرفت مينا حمد توفيق
Patient No : 3162-2023
Sex : Female Age : 42 Y
Financial Code : نفقة الدولة - جوستاف روسي
Department : طباط خارجية
Referring Doc :

Lab No. : 13009870
Request Date : 29-10-2025 11:33
Verification Date : 29-10-2025 11:55
Sample Type : EDTA Blood
Test Status : Routine
Analyzers : XN350_herml

Complete Blood Picture

Test	Result	Unit	Ref. Range
Hemoglobin	13.8	g/dL	12.0 - 16.0
RBCs	4.5	10 ⁶ /uL	4.0 - 6.5
Hematocrit (PCV)	38.3	%	36.0 - 50.0
MCV	85.3	FL	76.0 - 101.0
MCH	30.8	pg	26.0 - 32.0
MCHC	36.0	g/dL	31.5 - 34.5
RDW-CV	12.2	%	11.6 - 14.0
PLT	297	10 ³ /ul	150 - 450
WBCs, Total	6.1	10 ³ /uL	4.0 - 11.5

Differential Leucocyte Count :

	Relative		Absolute		
Neutrophils%	54.4	%	2.23	/cmm	2.00 - 7.00
Lymphocytes%	35.0	%	3.36	/cmm	1.50 - 3.50
Monocytes%	2.4	%	0.33	/cmm	0.20 - 1.00
Eosinophils%	3.3	%	0.15	/cmm	Up to 0.50
Basophils%	0.5	%	0.03	/cmm	Up to 0.10

Signature

Dr./Manal Mokhtar

Print Date : 29-10-2025 11:33

Page 1 of 1

Printing By : herml

25311121 / تاريخ

25311128 - 25311125 / ت

987 كورنيش، النيل، الملك الصالح